伊甸南投耆福長照機構｜長照人員在職訓練

安全移轉位技巧與實務演練

11 月 14 日（六）13:00–17:00｜南投市

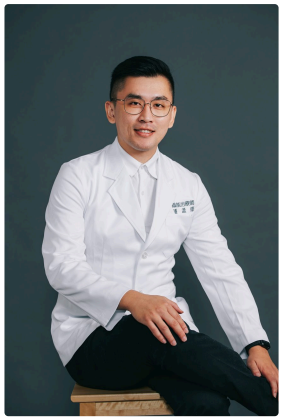
講師　鍾孟修 職能治療師｜愛迪樂居家職能治療所

掃描帶走這份簡報
mattsue1003.github.io/safe-transfer-deck/



開場

講師｜鍾孟修 職能治療師



- 愛迪樂有限公司 執行長（105/08 成立）
- 愛迪樂居家職能治療所 職能治療師所長
- 愛迪樂物理治療所 主管
- 愛迪樂新北、台中長期照顧服務機構 主管
- 關懷小丑協會 監事
- Homeseen 失智症遊戲包 共同創辦人

銀髮體適能教練｜皮拉提斯教練｜認知桌遊活動設計師｜MAT 功能性評估國際認證

開場

今天四小時怎麼走

13:00–13:40	**觀念**	為什麼會受傷、零抬舉、復能轉移位與協助轉移位
13:40–14:10	**保護自己**	髖鉸鍊、彎一腳直一腳、弓箭步（全員站起來練）
14:10–15:00	**床上移動、翻身到坐起**	示範後分組練
15:00–15:10	休息	
15:10–16:10	**床到輪椅**	角度怎麼擺、復能版、協助版、特殊轉移位技巧（分組演練）
16:10–16:40	**站走、輪椅下滑、推輪椅、上下車**	
16:40–17:00	**預防疲痛運動、資源、提問**	

今天的學員

居服員、日照照服員、居督、A 個管、日照社工、護理師、交通接送司機，60–70 人。

演練 3 人一組：個案、照顧者、觀察員，每項技巧輪一次。

開場

八大重點，照「一天的動線」走一遍

觀念 **零抬舉**	保護自己 **安全注意事項**	第 1 站 **床面上轉位**	第 2 站 **翻身到坐起**
第 3 站 **床到輪椅**	第 4 站 **輪椅到站走**	第 5 站 **輪椅下滑處理**	第 6 站 **推輪椅、上下車**

先想「人」
他能自己做多少？我要補多少？

再想「我」
腰打直、用腿、用體重，不用腰和手臂硬拉。

最後想「環境」
床高、輪椅角度、扶手腳靠、輔具。

原簡報的八大重點都在，順序改成個案從躺 → 坐 → 轉到輪椅 → 站走 → 出門。

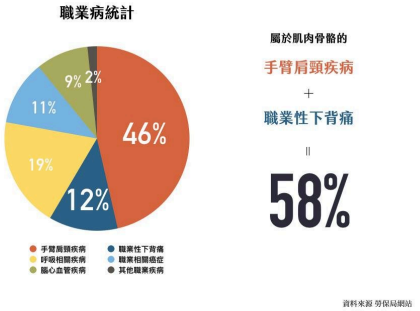
第一部分

為什麼要學轉移位

照顧工作最常受傷的地方，是自己的腰和肩。

為什麼要學轉移位

職業病統計：一半以上是肌肉骨骼問題



關於肌肉骨骼的
手臂肩頸疾病
＋
職業性下背痛
＝
58%

資料來源 勞保局網站

58%

手臂肩頸疾病 46%
＋職業性下背痛 12%

轉移位是每天重複幾十次的動作，一次做錯不會怎樣，天天做錯就會。

為什麼要學轉移位

猜猜看：哪一個是腰痛最常見的原因？

1. 椎間盤突出
2. 脊椎側彎
3. 肌肉拉傷
4. 骨刺

肌肉拉傷，約 70%。椎間盤與小面關節退化 10%、椎間盤突出 4%、椎間孔狹窄 3%。

點選項看答案。

關於腰痛的幾個迷思2

97 %	**機械型腰痛**
70 %	肌肉拉傷
10 %	椎間盤與小面關節退化
4 %	椎間盤突出
3%	椎間孔狹窄

阿舟物理治療 製圖

關於腰痛的幾個迷思（圖：阿舟物理治療）

為什麼要學轉移位

你是不是天生關節比較鬆？



Beighton 評分（滿分 9 分）

- A 小指後扳超過 90°（左右各 1 分）
- B 拇指碰到前臂（左右各 1 分）
- C 手肘過伸超過 10°（左右各 1 分）
- D 膝蓋過伸超過 10°（左右各 1 分）
- E 膝蓋打直彎腰、手掌貼地（1 分）

關節鬆的人更容易拉傷，更需要靠技巧和肌力保護自己。現場一起測。

圖：The Ehlers-Danlos Society，The Beighton Scoring System

為什麼要學轉移位

長期有運動，就能預防腰痛嗎？

1. 運動當然能有效預防腰痛
2. 運動應該不太能預防腰痛
3. **有些有、有些不行**

要看做的是什麼運動、做得夠不夠。基本量：每週 150 分鐘中等強度有氧，加上每週至少 2 天肌力訓練。課程最後會帶核心運動。



成人身體活動最低量建議（Move Your Way，美國衛生及公共服務部）

為什麼要學轉移位

腰痛發生了，會自己好轉嗎？

會　不會

大多數會慢慢好轉。但**超過四個月沒好轉就要就醫。**

這些情況不要等

- 腳麻、腳無力越來越明顯
- 大小便控制出問題
- 發燒、半夜痛醒、休息也不會緩解
- 跌倒或撞擊之後才開始痛

補充：以上是一般建議盡快就醫的警訊。

為什麼要學轉移位

坐著和站著，哪一個腰椎壓力比較大？

坐　站

坐著比站著大。站立當 100：坐正 140、坐著前傾 185、**彎腰搬東西 220**、**坐著彎腰搬 275**，平躺只有 25。

轉移位剛好就是「彎腰＋負重」。所以今天所有技巧都在做一件事：**不要彎著腰出力。**



各種姿勢下的腰椎間盤壓力（站立＝100）

第二部分

核心觀念

零抬舉、復能轉移位與協助轉移位、怎麼選方法。

核心觀念

零抬舉 No-Lift Policy

一套符合人體工學的安全照護觀念和做法，目的是避免工作職業傷害。

受傷的三個原因

- 人力難求
- 欠缺教育訓練
- 設備（輔具）不足





零抬舉三原則：鼓勵患者出力、水平取代垂直、善用輔具協助（圖：鄭凱文職能治療師）

核心觀念

什麼是「水平取代垂直」？



扶手可掀開



腳靠可掀開、可拆

- 把人「抬起來」是垂直，最傷腰。
- 讓屁股「平移過去」是水平，省力很多。
- 扶手、腳靠能掀開，輪椅才能貼近床，中間沒有障礙。
- 床面和輪椅座面調到一樣高，或讓出發的那邊略高一點。

選輪椅先看：扶手能不能掀、腳靠能不能掀。

核心觀念

復能轉移位 與 協助轉移位

復能轉移位：讓個案自己來

- **目的**：每一次移位都是訓練，把能力練回來。
- **誰出力**：個案為主。照顧者給口令、引導方向、在旁保護。
- **擺位**：輪椅與床夾 30–45°，個案抓對側扶手自己轉。
- **適合**：聽得懂指令、腳能撐一部分、坐得住。
- **代價**：比較花時間，要等他。

協助轉移位：照顧者帶著做

- **目的**：安全、省力地把人移過去。
- **誰出力**：照顧者為主，個案能幫多少算多少。
- **擺位**：輪椅貼著床，卡膝，弓箭步重心轉移，或用輔具。
- **適合**：幾乎無法出力、無法配合、當天狀況不好。
- **重點**：水平移動，不抬舉。

不是二選一。同一位長輩，早上有精神用復能，晚上累了用協助，都對。

核心觀念

復能怎麼做：做得到的不幫，做不到的才補

1. **先等 3–5 秒。**說完口令，給他時間反應。
2. **一次說一步。**「腳往後收」「身體往前」「手抓扶手」。
3. **只補他差的那一點。**差在站不起來，就補在骨盆；差在不敢轉，就站在患側。
4. **補的越來越少。**這次出三分力，下次試兩分。

協助由少到多

1. 口頭提示
2. 手勢、示範
3. 輕觸引導方向
4. 部分協助（補一點力）
5. 完全協助

補充：居家復能與日照的共同語言，寫紀錄時也可以用這五級描述。

核心觀念

四種轉位方式：哪一個不是零抬舉？

- 獨立轉位 Independent transfer
- 站立／蹲姿／坐姿軸轉位 Pivot transfer
- 滑板轉位 Sliding board transfer
- 依賴轉位 Dependent transfer



站立／蹲姿／坐姿軸轉位


依賴轉位

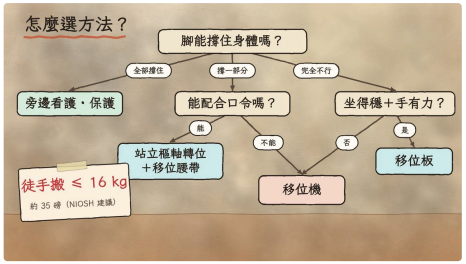
依賴轉位把人整個抱起來，不是零抬舉。前三種都有讓個案出力或用水平移動。

由上到下：個案出力越來越少。前兩種偏復能，後兩種偏協助。

核心觀念

動手之前，先問四個問題





腳能撐住嗎？能配合口令嗎？坐得穩嗎？手有力氣嗎？四題的答案決定用復能版還是協助版，以及要不要輔具或第二個人。

轉移位影片資料庫
有「先問四個問題」互動版

圖：鍾孟修〈轉移位技巧：不是比力氣，是比方法〉動畫

核心觀念

記住三個不要



- **不拉手臂**：肩膀容易拉傷、半脫位。
- **不從腋下抱**：壓迫腋下、傷肩。
- **不扭腰轉身**：照顧者閃到腰。

- 兩腳打開、膝蓋彎、靠近長輩
- 用腳步轉、用腿出力

核心觀念

什麼時候不要一個人徒手做

遇到這些情況，先停

- 個案完全無法出力，體重又比你重很多。
- 個案躁動、抗拒、聽不懂口令。
- 個案今天特別虛弱、頭暈、血壓不穩，或身上有管路。
- 你自己的腰、肩正在痛。
- 空間太小，輪椅擺不到位。

改成這樣做

- 找第二個人，一人顧上身、一人顧骨盆和腳。
- 用輔具：移位腰帶、移位板、滑布、轉盤、移位機。
- 回報居督或個管，申請輔具評估。

補充：美國 NIOSH 建議，徒手協助移位時照顧者實際承擔的重量以 16 公斤（35 磅）為上限，超過就該用輔具。

零抬舉的意思不是「更會抱」，是抱不動的時候不要硬抱。

第三部分

保護自己：安全注意事項

髖鉸鍊、彎一腳直一腳、必要時穿護腰。

保護自己：安全注意事項

安全注意事項：三件事

1 髖鉸鍊 Hip hinge

髖關節做屈曲和伸展，過程中脊柱保持挺直。彎的是髖，不是腰。

2 彎一腳、直一腳

鎖定髖關節，讓脊椎保持中立。弓箭步也有同樣效果。

3 必要時穿護腰

位置、鬆緊、時機、寬度都要對。髂嵴是關鍵。

接下來三段都請大家站起來一起做。

保護自己：安全注意事項

髖鉸鍊 Hip hinge：彎髖不彎腰

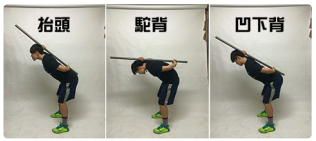


Squat（深蹲）與 Hinge（髖鉸鍊）的差別

- 後腦杓、上背、尾椎成一直線
- 核心穩定出力
- 臀大肌是主要出力肌群
- 後腳筋會有一點延展感
- 雙腳平均分配力量
- 膝蓋微彎

保護自己：安全注意事項

用一根棍子檢查自己



抬頭✗ ｜ 頭、背、尾椎三點貼棍○ ｜ 凹下背✗

現場練習：兩人一組，用雨傘或長尺貼在背後，往前彎 10 次，三點都不能離開。



示範：穿滑布手套時，上半身成一直線



洗碗也是髖鉸鍊（圖：聯新運醫）

保護自己：安全注意事項

彎一腳、直一腳，保護你的腰



床邊照顧：一腳膝蓋彎起來跪在床上（畫面：大愛新聞 台日長照交流）

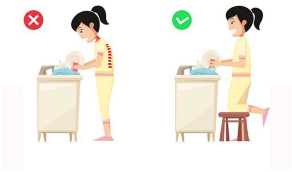


一腳彎放置床，腰更直不傷腰

做照顧之前，別忘了彎一腳膝蓋：跪上床、踩矮凳、或前後站。

保護自己：安全注意事項

生活上的應用，和它為什麼有效



洗碗：一腳踩小凳



一腳抬高時，骨盆不容易前傾，腰椎維持中立（圖：早安健康）



平時做單腳、雙腳抱膝伸展，可以舒緩腰部不適

弓箭步也有同樣的保護效果，而且可以移動重心，轉移位會一直用到。

保護自己：安全注意事項

弓箭步重心轉移：用體重帶人，不用腰拉人

1. 兩腳前後站開，比肩寬一點，膝蓋微彎。
2. 上半身維持髖鉸鍊的直線。
3. 重心從一腳慢慢移到另一腳，手只是「掛」著個案。
4. 腳尖朝向要去的方向，**用腳步轉，不扭腰**。

全員練習 1 分鐘

兩人面對面互抓前臂，一人弓箭步往後坐，把對方「帶」過來。感覺是腿在出力還是腰在出力。

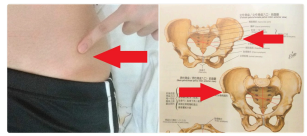
補充：這是等一下「輪椅貼床」協助版的核心動作，方向要先想好：**重心移動的方向 = 個案屁股要去的方向**。

保護自己：安全注意事項

護腰怎麼穿



位子	包住髂嵴（骨盆上緣），不要穿太高變成束腹。
鬆緊	貼身有支撐感，仍可順暢呼吸。
時機	搬移、出力的時候穿，休息時鬆開。
護腰寬度	後片夠寬，能撐住下背。



髂嵴是關鍵：手叉腰摸到的那一圈骨頭

保護自己：安全注意事項

護腰和姿勢的迷思



長期穿戴會肌肉萎縮嗎？

不會萎縮，但會有長期的心理依賴。

心理因素影響很大

一直覺得「我的腰很脆弱」，反而更容易痛（反安慰劑效應）。

動，還是關鍵。

沒有單一「正確」的姿勢；維持舒服的姿勢是安全的；脊椎很堅固，可以相信它。



打破姿勢的迷思

Slater D, et al. "Sit Up Straight": Time to Re-evaluate. JOSPT 2019;49(8):562-564｜PAIN-ED 中文版

第 1 站

床面上轉位技巧

往上移、左右移。先請個案自己來，再用床和滑布幫忙。

床面上轉位技巧

床上移動：先問兩個狀況

常見狀況

- 個案在床上往下滑了，怎麼辦？
- 個案不在床的正中央，怎麼辦？

復能版：個案能出力

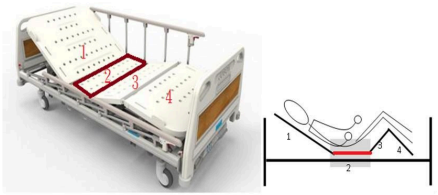
- 屈膝踩床、**移動腳、抬臀**
- **手撐、手拉**床欄協助
- 善用扶手欄杆和三折照顧床

協助版：個案依賴

- 善用滑布、移位板等輔具
- 兩人一起，不要一個人硬拉

床面上轉位技巧

善用三折照顧床



三折床：升高頭、升高腳、升高床

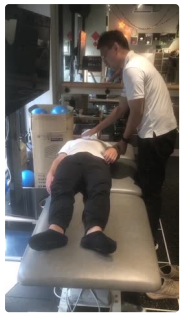
- **要坐起來**：先升腳、再升頭，屁股才不會往下滑。
- **要往上移**：先把床頭放平，不要在坐高的時候硬拉。
- **升高床面**到照顧者髖部附近，就不用彎腰。



示範影片：三折照顧床的應用（3 分 59 秒）

床面上轉位技巧

床上往上移、左右平移



特殊左右平移技巧（示範：鍾孟修）

往上移：個案屈膝踩床，照顧者固定腳掌，喊「一、二、三，屁股抬起來往上」。個案出不了力時，改用滑布。



日本長期照護 轉移位 1/4：調整病患在床上的位置（國興衛視）
YouTube｜dimvb
youtu.be/_ey9CAZAiGA

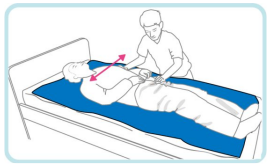


長輩臥床床上移位教學：照顧者必知的安全技巧
YouTube｜吱吱復健
youtu.be/7wVNkms-kS0

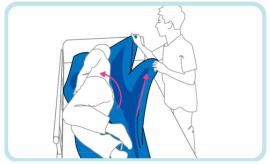
國興衛視《老師沒教的事》共四集，第 2、3 集連結放在最後的資源頁。

床面上轉位技巧

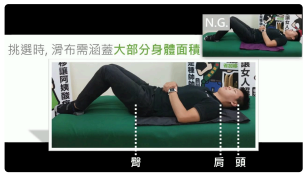
移位滑布、移位滑墊



床面上下左右移位



輔助翻身



挑選時，滑布要涵蓋大部分身體面積：臀、肩、頭

- 滑布把摩擦力降到很低，推的力氣只剩一點點。
- 鋪和抽都用翻身完成，不要抬人。



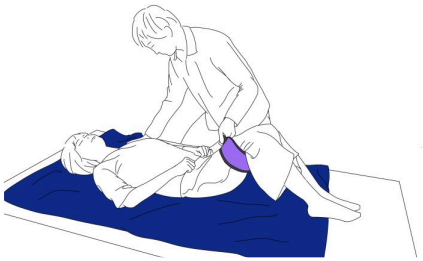
移位滑布示範影片（…
YouTube｜台灣安寧緩和護理學會
youtu.be/gUgG0HS6wyk



滑布：翻身、擺位…
YouTube｜ouhnhs
youtu.be/arqG_2ftfOY

床面上轉位技巧

滑墊＋固定帶，更省力也更安全



省力向上移位

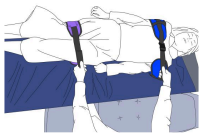


省力側向拉動移位

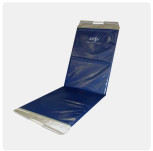
拉的時候一樣用弓箭步重心轉移，手臂打直當繩子，不要用手臂彎曲去拉。

床面上轉位技巧

床到床、床到仰躺式輪椅：硬式滑板與軟式滑板



平躺移位



硬式滑板



軟式滑板

1 翻身　2 插入板子　3 躺平　4 推身體　5 抽出板子

注意中間的空隙：空隙大用硬式，空隙小、床面等高可用軟式。



多人一起，用推的，不用抬的

第 2 站

翻身到坐起轉位技巧

翻身是所有床上照顧的第一步，也是最容易請個案自己做的一步。

翻身到坐起轉位技巧

協助翻身技巧



- **減少底面積**：手抱胸、膝蓋彎起來。
- **增加上下肢力臂**：膝蓋立得越高越好推。
- **鼓勵患者自行出力**：頭先轉、手伸過去抓床欄。
- **善用輔具**：照顧床、床欄、翻身布。



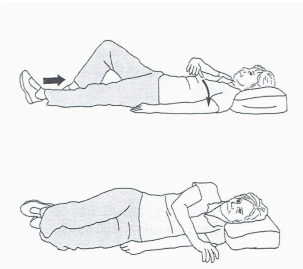


長輩臥床床上移位教…
YouTube｜吱吱復健
youtu.be/7wVNkms-kS0

照顧者扶的是**肩膀和骨盆**，不是拉手。

翻身到坐起轉位技巧

翻身方式：腰不舒服的人適合哪一種？



木頭式翻身　分節式翻身

木頭式翻身。肩膀上肢和骨盆下肢一起翻，脊椎不扭轉，適合腰痛、脊椎術後。

木頭式	肩膀上肢、骨盆下肢**一起翻**
分節式	肩膀上肢、骨盆下肢**分階段翻**，比較省力

翻身到坐起轉位技巧

翻身要翻好側，還是患側？

純翻身

翻向患側比較容易。

好手好腳在上面，可以自己推、自己勾。

要鼓勵個案獨立坐起

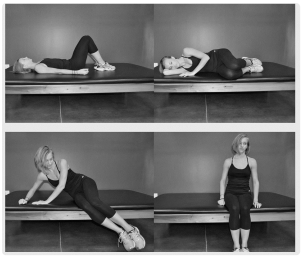
翻向好側比較容易坐起。

但翻身這一步會比較有挑戰，因為要帶著患側翻過去。

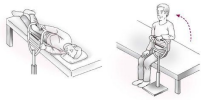
還要看環境：照顧床有沒有靠牆，決定了他只能從哪一邊下床。

翻身到坐起轉位技巧

翻身坐起：翹翹板原理



- **腳先下床**，腳的重量往下，上半身就容易起來。
- 照顧者一手在**肩頸部**提供支持。
- 一手在**骨盆部**提供協助，往下壓。
- 鼓勵個案**用手臂撐床**。





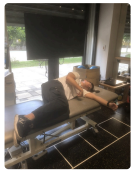


協助銀髮族長輩下床…
YouTube｜光合物理治療所
youtu.be/m0ZQBZpjmxc

翻身到坐起轉位技巧

復能版：鼓勵個案自己翻身坐起

- 好腳勾住患腳，一起帶下床。
- 好側在下方比較容易撐起來。
- **上身和床邊留距離**：距離夠，手臂才撐得起來。
- **下身和床邊留距離**：距離夠，腳才有地方放。



坐起小技巧：善用上半身的空間（示範：鍾孟修）



偏癱病人自己床上移位：往健側翻身、坐起（門諾醫院職能治療）
YouTube｜門諾健康頻道
youtu.be/1STmEXjv6ek



偏癱病人自己床上移位：往患側翻身、坐起（門諾醫院職能治療）
YouTube｜門諾健康頻道
youtu.be/Y9Im3yBsBpk



科學性的移位技能 EP2：平躺到起身移至輪椅
YouTube｜Jubo Care 智齡照顧
youtu.be/WqmQtrr9TrI

翻身到坐起轉位技巧

坐起的輔具，和直接坐起的做法



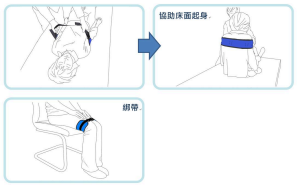


起身拉繩



自行臥床起身、移動患肢

個案手有力時，拉繩、床欄都能讓他自己起來。



直接坐起的照顧轉位技巧

善用照顧床，**先把頭部調高**，要補的角度就少一半。

第 3 站

床到輪椅轉位技巧

今天的重點。先擺對角度，再決定用復能版還是協助版。

床到輪椅轉位技巧

動手前 30 秒：先檢查這六件事

輪椅

剎車踩了嗎？腳踏板收起來了嗎？

床

高度和輪椅座面差不多嗎？床輪鎖了嗎？

地面和鞋子

地板乾的嗎？個案穿防滑鞋或止滑襪了嗎？

管路

尿管、鼻胃管、氧氣管夠長、不會被扯到嗎？

個案狀況

今天精神好嗎？剛坐起來會不會頭暈？先坐 30 秒再動。

說明

告訴他要去哪裡、怎麼做，約好口令「一、二、三」。

補充頁。多數意外不是技巧不好，是剎車沒踩、腳沒擺好、沒先講。

床到輪椅轉位技巧

床到輪椅、輪椅到床：六個步驟

1. **擺輪椅**：個案好邊接近輪椅，剎車，與床面夾 0–45°，注意床的高度。
2. **坐到床緣**：讓個案移動到邊緣，腳踩地。
3. **預擺**：先把腳和骨盆擺到稍微偏向轉位方向。
4. **穩定膝蓋**：膝蓋微彎、身體保持直立。卡雙膝、卡單壞、卡單好、不卡，或用膝蓋綁帶。
5. **抓握**：照顧者抓肩胛骨、腰帶或褲頭；個案抓照顧者衣物、環抱，或抓支撐面、扶手。
6. **弓箭步**：重心轉移，注意方向。

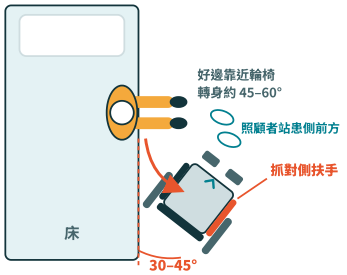


反過來從輪椅回床，步驟一樣，方向相反，一樣讓好邊靠近目的地。

床到輪椅轉位技巧

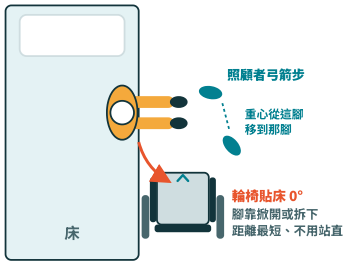
輪椅跟床：30–45 度，還是貼著？

個案有能力：夾 30–45°



能撐起屁股、手能**抓住對面的扶手**。他自己轉，你保護。這是**復能轉移位**。

幾乎都要你幫忙：輪椅貼著床



沒有能力站、抓不住扶手。輪椅貼床，照顧者用**弓箭步**把人平移過去。這是**協助轉移位**。

兩個都對，看人。判斷只要一句：他抓得到對面扶手、撐得起屁股嗎？

床到輪椅轉位技巧

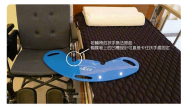
為什麼這樣分？

	夾 30–45°	輪椅貼床（0°）
個案能力	能站或半站、能抓握、聽得懂口令	站不起來、無法抓握或無法配合
誰出力	個案為主	照顧者為主
為什麼	對側扶手剛好在伸手可及的地方；腳有踩步轉身的空間；只需要轉小半圈	屁股移動的距離最短；不必站直，屁股離床一點就能平移；水平取代垂直
輪椅條件	一般輪椅就可以	扶手、腳靠最好能掀開
照顧者	站患側前方，口令加保護	卡膝、抓腰帶，弓箭步重心轉移











看圖討論：這四張各是哪一種擺法？為什麼？

床到輪椅轉位技巧

第一步：怎麼協助坐到床緣



臀部一邊一邊往前移

手協助推拉

一手在骨盆後方往前帶，一手在對側膝蓋往後推，注意身體方向和手推拉的方向相反。

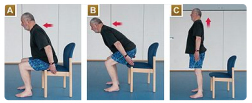
左右擺盪法

身體先倒向左邊，右邊屁股變輕就往前挪；再換邊。像「屁股走路」。


減少腰部負擔的各種轉位方法（日本，產業保健物理治療）
YouTube｜産業保健の理学療法
youtu.be/YavQPtwSk2I

床到輪椅轉位技巧

頭超過腳尖，個案才能幫你出力



坐到站：身體前傾，頭過腳尖，屁股才離得開椅面

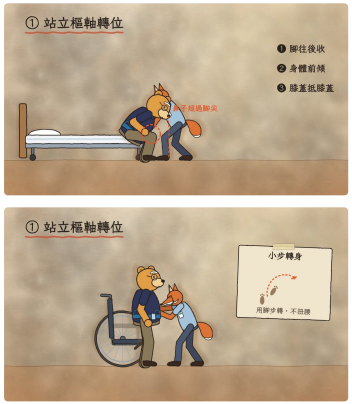


○ 個案有前傾｜✗ 個案沒前傾，照顧者的腰負擔大

口令：「腳往後收、鼻子超過腳尖、屁股翹起來。」

床到輪椅轉位技巧

復能版：個案情況較佳時的站立軸轉位



兩個重點

- 個案**抓住對側扶手**。
- 照顧者**站在患側**保護、引導。

口令一次一步：腳往後收 → 身體往前 → 手抓對面扶手 → 屁股離床 → 小步轉 → 摸到椅子再慢慢坐。


協助長輩從床移位到輪椅：站姿移位法（康揚輔具）
YouTube｜Karma Medical 康揚輔具
youtu.be/aqQdc4vCHIE



蹲姿與站姿軸轉位 Squat and Stand Pivot Transfer（Craig Hospital）
YouTube｜Craig Hospital
youtu.be/MkWIMZyYyXk

原簡報此頁的短網址已失效，改放兩支內容相同主題、可正常播放的影片。

床到輪椅轉位技巧

中風偏癱：輪椅放健側



- 輪椅放在**健側**，用好手、好腳出力，轉身更順。
- 照顧者護住**患側膝蓋**。
- **千萬別拉患側手**，肩膀容易半脫位、疼痛。

回程（輪椅到床）也一樣：調整輪椅方向，讓健側靠近床。

床到輪椅轉位技巧

預先把腳和骨盆擺到偏轉位的位置



示範影片：先擺腳、再轉位

- 靠近輪椅的那隻腳往前半步，另一隻腳往後。
- 骨盆先轉向輪椅一點，等一下要轉的角度就更小。
- 腳沒先擺好，轉到一半會**絞在一起**，這是最常見的跌倒原因。

先擺腳，再起身。

床到輪椅轉位技巧

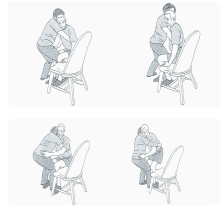
膝蓋要不要卡？卡哪一邊？



卡單膝（片膝）與卡雙膝（兩膝）

卡雙膝	兩腳都沒力，照顧者用雙膝夾住
卡單壞	只穩定沒力的那隻腳
卡單好	現場示範討論：什麼情況會卡好腳？
不卡	個案兩腳都撐得住，只需保護
膝蓋綁帶	用輔具固定雙膝，照顧者的腳空出來

討論題：只卡一邊膝蓋時，應該穩定靠近輪椅那一側，還是另外一側？



床到輪椅轉位技巧

蹲姿或站立軸心轉位



膝蓋微彎、身體保持直立；個案不必站到全直

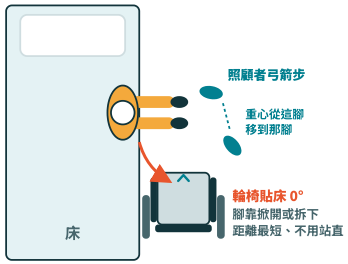
- **站立軸轉**：個案站得起來，轉身坐下。
- **蹲姿軸轉**：站不直沒關係，屁股離開床面、半蹲著轉過去。
- 照顧者抓腰帶或褲頭，重心壓低，和個案一起移動。



How to Do a Squat and Stand Pivot…
YouTube｜Craig Hospital
youtu.be/MkWIMZyYyXk

床到輪椅轉位技巧

協助版：輪椅貼床＋弓箭步

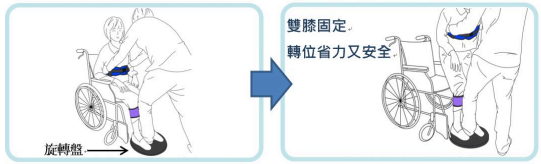


1. 扶手、腳靠能掀就掀開，**輪椅貼著床**，剎車。
2. 個案坐到床緣，腳踩地，靠輪椅的腳在前。
3. 照顧者卡膝，抓腰帶或褲頭，個案上身靠在照顧者肩側。
4. 讓個案**頭過腳尖**，屁股離床一點點就好，不必站直。
5. 照顧者**弓箭步**，重心從遠離輪椅的腳移到靠近輪椅的腳，把屁股水平帶到座面。
6. 坐下後再調整坐深。

不是抱起來再放下，是讓屁股沿著水平線滑過去。

床到輪椅轉位技巧

輔具：旋轉盤



旋轉盤：雙膝固定，轉位省力又安全

- 個案腳踩在轉盤上，站起後整個人跟著盤轉，不用踩步。
- 適合能撐住體重、但腳步踩不出去的個案。
- 照顧者要固定雙膝，避免轉太快。





移位小幫手：移位轉盤使用方式
YouTube｜臺東縣輔具資源中心
youtu.be/PbyM5cQ7KCk

床到輪椅轉位技巧

輔具：移位板，坐姿軸心轉位





轉移位上床



坐姿軸轉位 Sit-Pivot Transfer

平移移位，省力又安全。手有力、坐得穩的個案可以自己來，是輪椅使用者最重要的獨立技巧。



上下車、椅子之間也能用



坐姿平移 移位法（瞭…
YouTube｜瞭輔具
youtu.be/Zne6RFIlrpc

進階

特殊轉移位技巧

個案幾乎無法出力時的協助版做法。都是水平移動，不是抱起來。

特殊轉移位技巧

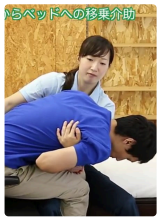
五種特殊轉移位技巧

椅子轉位法



照顧者坐在椅子上，把個案的身體放在自己大腿上帶過去。

人體蹺蹺板



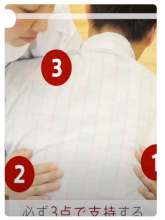
個案上身前傾趴在照顧者身上，屁股自然翹起。

雙腰帶



兩條帶子分別帶骨盆，照顧者手不用彎腰去抓。

身體支點



用骨盆側、鎖骨附近、肩或腋三點支撐。

照顧型轉位



減少腰部負擔的各種協助做法總整理。

共同原則：個案上身前傾、重心到腳上、屁股沿水平線移動。先看影片，再分組試。

特殊轉移位技巧

椅子轉位法（依賴型）



利用右手把臀部抬起來



慢慢坐回自己的椅子上

- 照顧者坐著做，腰不用彎。
- 個案上身趴在照顧者大腿與肩上。
- 用照顧者身體的轉動帶個案過去。



日本長期照護 轉移位…
YouTube｜dimvb
youtu.be/ITtDY2vXpC4

畫面：國興衛視《老師沒教的事：長期照護方法大公開》

特殊轉移位技巧

人體蹺蹺板（依賴型）



- 照顧者坐在個案旁邊或半蹲在前方。
- 個案上身前傾，重量放在照顧者背上或肩上。
- 頭往下，屁股就往上，像蹺蹺板。
- 屁股離床後，水平轉到輪椅。



減少腰部負擔的各種轉位方法（日本）
YouTube｜産業保健の理学療法
youtu.be/YavQPtwSk2I

特殊轉移位技巧

雙腰帶轉移位技巧（依賴型）



- 帶子繞過個案骨盆下方，照顧者抓帶子，不用彎腰去抓褲頭。
- 照顧者身體往後坐，個案就被帶起來。
- 一樣要卡膝、頭過腳尖。



好神帶｜幫幫移位系列（JUST4U 強生醫療…
YouTube｜JUST4U強生醫療儀器
youtu.be/jDkzzJeJ-Qc

特殊轉移位技巧

身體支點轉移位技巧：一定用三點支撐





三點支撐



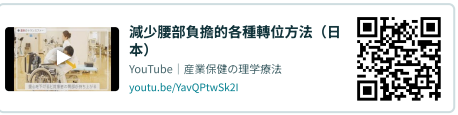
個案軀幹較軟時：骨盆側、鎖骨附近、肩或腋

- ① 骨盆側　② 另一側骨盆　③ 上背或肩胛
- 軀幹軟的個案：改撐鎖骨附近與肩、腋，避免往前倒。

畫面：日本介護技術教學影片（產業保健の理学療法）

特殊轉移位技巧

照顧型轉位技巧總整理，和日本轉移位資料庫



減少腰部負擔的各種轉位方法（日本）
YouTube｜産業保健の理学療法
youtu.be/YavQPtwSk2I



別再用抱的！輪椅移位超省力不傷腰（健康 2.0 feat. 新北市輔具…
YouTube｜健康2.0
youtu.be/aLPXgRCxzmA



日本轉移位 YouTube 熱門影片，搭配中文翻譯重點，點選就能看。

安心移位｜日本長照教學影片庫
anxin-transfer-guide.pages.dev/

特殊轉移位技巧

分組演練：床到輪椅

分組方式
3 人一組：個案、照顧者、觀察員。每個情境做完就輪替。

三個情境

1. **能站、能抓**：復能版，輪椅夾 30–45°，只給口令。
2. **右側偏癱**：輪椅放健側，保護患側膝。
3. **幾乎無法出力**：協助版，輪椅貼床，弓箭步。

觀察員檢核

- 輪椅剎車了嗎？角度對嗎？
- 個案腳踩穩、腳有先擺好嗎？
- 有說口令、有等個案嗎？
- 個案頭有過腳尖嗎？
- 照顧者是彎髖還是彎腰？
- 是用腳步轉，還是扭腰？
- 坐下時有沒有「摔」進輪椅？

第 4 站

輪椅到站走轉位技巧

坐到站是每天做最多次的訓練。

輪椅到站走轉位技巧

坐站訓練：兩種做法的差別

手撐椅子扶手站起來

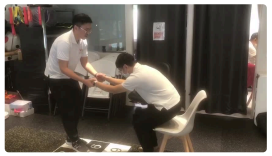


- 動作較為**安全**
- 下肢訓練效果差

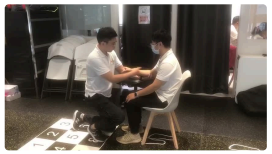
手扶前方、身體前傾站起來



- 下肢訓練效果**好**
- 動作較為挑戰



示範：照顧者在前方牽引站起



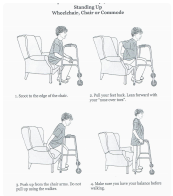
示範：照顧者蹲在前方引導

撐扶手比較安全；**手往前、重心到腳上**，腿才真的在出力。現場兩種都試試看。

輪椅到站走轉位技巧

坐到站、站到坐

坐到站



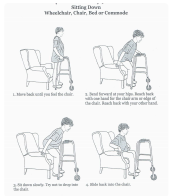
自己來



照顧者協助

坐到椅緣 → 腳往後收、鼻子過腳尖 → **手撐椅子扶手站起來，不要拉助行器** → 站穩了再走。

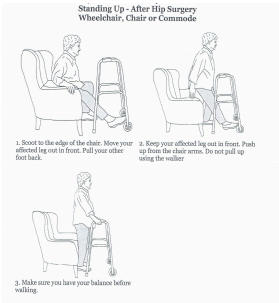
站到坐



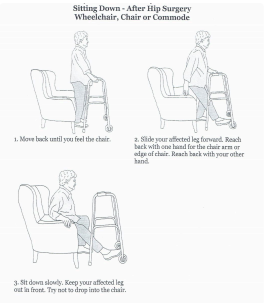
後退到小腿碰到椅子 → 身體前傾，一手往後摸扶手 → 慢慢坐，不要「摔」下去 → 往後坐深。

輪椅到站走轉位技巧

髖關節或下肢手術患者的坐站



站起來 Standing Up



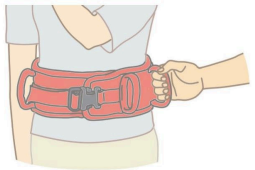
坐下去 Sitting Down

- 起身前，**手術那隻腳往前伸**，好腳往後收。
- 手撐椅子扶手起身，不要拉助行器。
- 坐下前一樣先把患腳往前滑。

髖關節活動限制依手術方式不同，以醫師、治療師交代為準。

輪椅到站走轉位技巧

腰帶真的好重要



◎ 移位腰帶讓照顧者輕握著就可控制好個案重心

移位腰帶讓照顧者輕握著，就可以控制好個案重心





站在斜後方，手輕握腰帶把手；有狀況時讓長輩靠在自己身上

- **觀感、心理因素**：不用抓褲頭、不用抱。
- **安全好施力**：抓的是骨盆，就是重心。
- **避免肩頸手臂受傷**：個案和照顧者都是。



移位腰帶 有夠厲害（…
YouTube｜瞭輔具
youtu.be/V0YH7atZ7Kk

輪椅到站走轉位技巧

跌倒了怎麼辦？

先檢查，別急著拉。有沒有劇痛、頭暈、腳變形、撞到頭？有就不要動，打 119。

1. 美人魚側坐
2. 四足跪
3. 單膝下跪
4. 手撐椅子、腳出力





跌倒後自己起身的九個步驟（圖：Stay On Your Feet，西澳）



跌倒後，如何從地上…
YouTube｜JUST4U強生醫療儀器
youtu.be/dEdMk-P5dbY



跌倒後，如何從地上…
YouTube｜JUST4U強生醫療儀器
youtu.be/ebyAduEm3k

他人協助時是「引導」，搬兩張椅子，一張給他撐、一張給他坐。

第 5 站

長輩輪椅下滑處理方式

先把人坐回去，再找出為什麼會滑。

長輩輪椅下滑處理方式

長輩在輪椅上往下滑，怎麼辦？



- 不要從腋下硬往上提。
- 抓個案**交叉的前臂**，先讓他**前傾**，再往後帶。
- 或左右擺盪，一邊一邊往後挪。



解決輪椅前滑的 5 招乾坤大挪移神功（瞭輔具）
YouTube｜瞭輔具
youtu.be/RcP_wUOSvWg

一直滑，要回頭檢查：座深太長？座墊太滑？腳踏板太高？骨盆帶位置？

長輩輪椅下滑處理方式

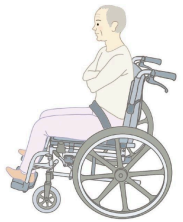
止滑坐墊，和骨盆帶的位置



單向止滑坐墊：只能往後、不會往前



◎ 正確的骨盆帶位置



○ 正確的骨盆帶位置

◎ 骨盆帶位置太高，固定效果差，坐姿容易前滑



✗ 位置太高，固定效果差，容易前滑

骨盆帶要壓在髂前上棘下方、往後下方 45° 拉，不是綁在肚子上。

圖片來源：楊忠一《行動輔具怎麼選怎麼用》(2019)

第 6 站

推輪椅與上下車

高低差、斜坡、縫隙，還有司機每天都要做的上下車。

推輪椅與上下車

推輪椅：前推、後推、翹起前推

照顧者依不同環境，協助推輪椅的安全模式

	前推	後退	翹起前推
上緩坡	○	不適用	不適用
下緩坡	○	費力	不適用
上陡坡	○	不適用	不適用
下陡坡	危險	○	不適用
上 5-20 公分平台	不適用	不適用	○
下 5-20 公分平台	危險	○	需熟練技巧
過 0.5-5 公分門檻	危險	○	○
地面縫隙	危險	○	○
崎嶇路面	危險	○	費力 需熟練技巧

備註：依「無障礙法規」規定：坡度小於 1：12（約 5 度角）是「緩坡」。坡度大於 1：12 則稱為「陡坡」。

照顧者依不同環境，協助推輪椅的安全模式

前推
平地、上坡、下緩坡

後推
下陡坡、下平台、過門檻與縫隙

翹起前推
上平台、過門檻與縫隙

下陡坡、下平台用前推很危險，個案會往前栽。倒退著下，照顧者在下方擋。

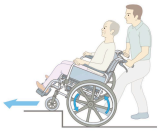
坡度小於 1:12（約 5 度）是緩坡，大於則是陡坡。

圖片來源：楊忠一《行動輔具怎麼選怎麼用》(2019)

推輪椅與上下車

平台、門檻、縫隙

平台

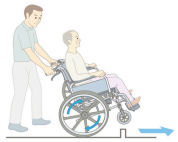


上：翹起前推



下：後退

門檻



前進：翹起前輪



後退通過

縫隙



前進：翹起前輪

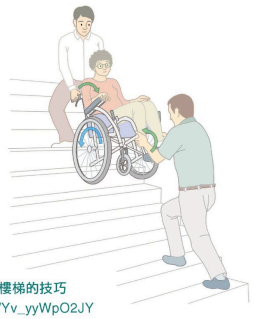


後退通過

圖片來源：楊忠一《行動輔具怎麼選怎麼用》(2019)

推輪椅與上下車

雙人手推輪椅上下樓梯



影片：輪椅上下樓梯的技巧
https://youtu.be/Yv_yyWpO2JY

- 輪椅後傾，後輪貼著階梯，一階一階滾。
- 後方的人主要出力，前方的人抓骨架（不是抓腳踏板）穩定方向。
- 先喊口令再動，每一階都停一下。



輪椅手動上下樓梯操作教學：雙人協力（瞭輔具）
YouTube｜瞭輔具
youtu.be/pePSC1tIL6I

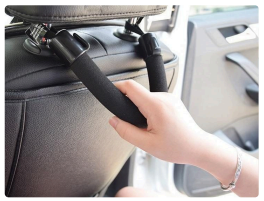
圖片來源：楊忠一《行動輔具怎麼選怎麼用》(2019)

推輪椅與上下車

猜猜看，這是什麼輔具？







看答案

汽車安全扶手。卡在車門鎖扣上當把手；另外還有掛在頭枕上的拉把、放在座椅上的旋轉座墊。

推輪椅與上下車

上下車移位



1. 先將座椅向後移動，騰出足夠的空間 。



2. 向後移動直到你感覺大腿後側碰到座椅。



3. 一手放在儀表版，一手抓座椅，將頭低下放入車內。



3. 坐入車內，將腳收入車內。

1. 先把座椅往後移，騰出足夠的空間。
2. 背對座椅後退，直到大腿後側碰到座椅。
3. 一手扶儀表板、一手扶座椅，**屁股先坐**，把頭放低。
4. 坐穩之後，再把腳一隻一隻收進車內。

給交通接送司機：輪椅一樣夾 30–45° 靠近車門，剎車。下車順序相反：腳先出來踩穩，再起身。



科學性的移位技能 EP3：由輪椅上下車（Jubo Care）
YouTube｜Jubo Care 智齡照顧
youtu.be/jN6fDjMdn0s

收尾

保養自己，帶走資源

照顧別人之前，先把自己的腰顧好。

保養自己，帶走資源

預防痠痛的運動

抗彎曲：橋式、骨盆後傾



骨盆後傾



橋式

貓牛式、鳥狗式



貓牛式：反覆 5–10 次（圖：Heho 健康）



鳥狗式（圖：健康 2.0）

抗旋轉：Pallof Press





Pallof Press 示範
YouTube｜StKatesAthletics
youtu.be/nFspBRHke4w

轉移位最怕扭腰，抗旋轉就是在練「不被扭走」。

保養自己，帶走資源

轉移位資料庫：回去還可以查

轉移位影片資料庫
mattsue1003.github.io/transfer-video-library/

145 支影片，依情境、個案能力、人力篩選；有「先問四個問題」互動版。

安心移位｜日本長照教學影片庫
anxin-transfer-guide.pages.dev/

日本轉移位熱門影片，搭配中文重點。

長照轉移位技巧｜網頁簡報
mattsue1003.github.io/transferskill/

另一份轉移位技巧的網頁簡報，可以對照複習。

保養自己，帶走資源

輔具資料庫與補助查詢

長照輔具資料庫
mattsue1003.github.io/long-term-care-assistive-devices-database/

依功能、食衣住行樂查詢輔具，移位類輔具也在裡面。

生活魔法師｜輔具補助查詢
mattsue1003.github.io/longtermcare/

長照、身障輔具補助項目與金額查詢。

臉書｜鍾孟修 Matt 職能治療師
www.facebook.com/100063748491881

YouTube｜鍾孟修 職能治療師
www.youtube.com/@tedandetable

保養自己，帶走資源

補充：移位輔具的長照補助

代碼	項目	給付上限	年限
ED01	移位腰帶	1,500 元	3 年
ED02	移位板	2,000 元	5 年
ED03	人力移位吊帶	4,000 元	3 年
ED04	移位滑墊 A 款	3,000 元	5 年
ED05	移位滑墊 B 款	8,000 元	5 年
ED06	移位轉盤	2,000 元	3 年
ED07	移位機	購置 40,000 元；租賃每月 2,000 元	10 年
ED08	移位機吊帶	6,000 元	3 年

- 輔具與居家無障礙額度：每 3 年 4 萬元。
- 部分負擔：一般戶 30%、中低收入戶 10%、低收入戶 0%。
- 申請窗口：各縣市長照管理中心，1966。

依衛福部長照給付及支付基準整理，金額與規定以最新公告和南投縣輔具資源中心說明為準。其他項目可用上一頁的「輔具補助查詢」。

保養自己，帶走資源

更多延伸影片



日本長期照護 轉移位 2/4（國興衛視）
YouTube｜dimvb
youtu.be/juSLVq6Kdv0



日本長期照護 轉移位 3/4（國興衛視）
YouTube｜dimvb
youtu.be/uE44eK7gQPY



科學性的移位技能 EP2：平躺到起身移至輪椅
YouTube｜Jubo Care 智齡照顧
youtu.be/WqmQtrr9TrI



別再用抱的！輪椅移位超省力不傷腰
YouTube｜健康2.0
youtu.be/aLPXgRCxzmA



協助銀髮族長輩下床的方法
YouTube｜光合物理治療所
youtu.be/m0ZQBZpjmxc



坐姿平移 移位法
YouTube｜瞭輔具
youtu.be/Zne6RFIIrpc

保養自己，帶走資源

今天帶走五句話

1. 做得到的不幫，做不到的才補。
2. 有能力，輪椅夾 30–45°、抓對側扶手；沒能力，輪椅貼床、弓箭步。
3. 頭過腳尖，屁股才起得來。
4. 彎髖不彎腰，用腳步轉不扭腰。
5. 水平取代垂直，能用輔具就用輔具。

謝謝大家。有問題現在問，或到臉書「鍾孟修 Matt 職能治療師」留言。